今日論文 • 第 05 篇 公開全文

血府逐瘀口服液輔助治療穩定型心絞痛：多中心雙盲安慰劑對照隨機試驗

Effects of Xuefu Zhuyu oral liquid as adjunctive treatment for stable angina: a randomized controlled trial

作者 Cao W, Liao S, Zhou L, Li G, Jiang J, Lv W, Dong B, Liu L, Zhang J, Wang Y, Ouyang W, Du Y, Wen Z 等

期刊 Frontiers in Medicine（2026年4月29日）

識別碼 DOI 10.3389/fmed.2026.1787481 • 註冊號 ChiCTR1900026899

取用 公開全文

官方連結（點擊即可打開）

- Frontiers 公開全文 https://www.frontiersin.org/journals/medicine/articles/10.3389/fmed.2026.1787481/full
- Europe PMC 公開 PDF https://europepmc.org/articles/PMC13167926?pdf=render
- DOI https://doi.org/10.3389/fmed.2026.1787481

研究是什麼

在中國六間醫院進行的多中心、隨機、雙盲、安慰劑對照試驗，評估血府逐瘀口服液（XZOL）作為標準抗心絞痛治療的輔助用藥，對穩定型心絞痛（氣滯血瘀證）疼痛強度的療效與安全性。第一作者單位包括香港浸會大學中醫藥學院。

方法要點

- 納入 30–75 歲、符合穩定型心絞痛及氣滯血瘀證、CCS I–III 級、有冠狀動脈疾病客觀證據、每周至少兩次發作、入組前兩周疼痛 VAS ≥3 分的患者。
- 2020年6月至2022年6月篩選 263 人，隨機 152 人；全分析集（FAS）148 人，兩組各 74 人。加於常規抗心絞痛治療，XZOL 或外觀、味道匹配的安慰劑，每次 20 mL、每日三次，共 12 周，再隨訪 12 周。
- 主要終點：第 12 周平均心絞痛疼痛 VAS（10 cm）相對基線的改變。次要終點包括第 24 周 VAS、發作頻率及持續時間、急救硝化甘油使用、CCS 分級、證候、西雅圖心絞痛問卷、EQ-5D-5L 及 PSQI。

主要結果

- 第 12 周 FAS：XZOL 組 VAS 多降 0.63 分（校正差 −0.63，95% CI −1.12 至 −0.14；P=0.012）。第 24 周仍見差距（−0.47，95% CI −0.94 至 −0.002；P=0.049）。符合方案集（PPS）效應更大（第 12 周 −1.11）。
- 急救硝化甘油使用率：第 12 周 2.7% 對 13.5%（P=0.016）；第 24 周 2.7% 對 12.2%（P=0.029）。發作頻率、持續時間、CCS、生活質素等其餘次要終點組間大多無統計學差異。
- 作者預先設定的優效界值為 1.7 分，實際 FAS 效應未達此界值，整體止痛幅度屬中等偏小。CCS III 級亞組可能得益較明顯，但人數少，僅供參考。
- 不良事件兩組均為 10.5%。XZOL 組有 1 例不穩定心絞痛，監察委員會判定與試驗藥物無關；1 例肝功能異常被視為可能相關，經處理後完成試驗。

中醫診所臨床啟示

- 氣滯血瘀型胸痹、穩定型心絞痛患者，可將血府逐瘀口服液作為輔助討論，但須維持原有西藥及心臟科隨訪，不能取代抗心絞痛藥或血運重建評估。
- 向患者如實說明：止痛幅度不大，未達到試驗預設的 1.7 分優效界值；較明確的是急救硝化甘油使用減少。
- 急性胸痛加重、氣促、出冷汗、疼痛放射或症狀性質改變，須即時轉急症。此研究與 11-11 簡報的痛經試驗為同一成藥、不同適應症，不可互相套用結論。

限制與解讀注意

- 主要終點為主觀 VAS，安慰劑組亦有明顯改善；試驗在疫情期間進行，完成隨訪人數少於隨機人數。
- 中藥口味難以完全致盲；只納入中國氣滯血瘀證患者，外推有限。
- 未以運動耐量或心肌灌注等客觀功能指標作為主要終點。

聲明：這份 PDF 由新聞bot 根據已核實的摘要及（如屬公開取用）論文頁面撰寫中文摘要，方便診所快速閱讀，並非出版社官方譯本，亦不是論文全文。關鍵數據請以官方全文為準。本摘要供專業參考，不能代替個別患者的臨床判斷。